

Fibrilación Auricular: Antiarrítmicos

PERFIL EUNACOM 1.01.1.012

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Los antiarrítmicos son fármacos esenciales para el manejo de las arritmias cardíacas, especialmente la **Fibrilación Auricular (FA)**. Se clasifican según su mecanismo de acción y su uso principal puede ser para **control de la frecuencia** o **control del ritmo**.

Antiarrítmicos para el Control de la Frecuencia (Bradicardizantes)

Estos fármacos buscan reducir la velocidad de conducción a través del nodo AV, disminuyendo así la frecuencia ventricular en arritmias supraventriculares como la FA.

Clases Farmacológicas

TABLA 1.6.1: CLASE VS NOMBRE COMÚN			
CLASE	NOMBRE COMÚN	EJEMPLOS ORALES	EJEMPLOS ENDOVENOSOS
II	Beta-bloqueadores	Atenolol (elección), Carvedilol	Propranolol (más usado), Esmolol, Metoprolol
IV	Bloqueadores de los canales de calcio no dihidropiridínicos	Verapamilo, Diltiazem	Verapamilo, Diltiazem
V	Digitales (Glucósidos Cardíacos)	Digoxina (más usada), Anatócido C	Digoxina, Anatócido C

NOTA CLÍNICA

Los **beta-bloqueadores** (Clase II) y los **bloqueadores de los canales de calcio no dihidropiridínicos** (Clase IV) actúan principalmente en el nodo AV, ralentizando la conducción y la frecuencia cardíaca. Los **digitales** (Clase V) tienen un efecto inotrópico positivo y cronotrópico negativo, también ralentizando el nodo AV.

Antiarrítmicos para el Control del Ritmo

Estos fármacos buscan revertir la arritmia a **Ritmo Sinusal** normal y mantenerlo.

Clases Farmacológicas

- | Clase | Mecanismo de Acción | Ejemplos Orales y/o Endovenosos |
Notas 1. **Amiodarona**: Es el más utilizado en la práctica.
- Flecainida y Propafenona**: Son antiarrítmicos Clase IC.
- Se utilizan para el control del ritmo, a menudo de forma "SOS" (según necesidad) en caso de FA.
- Su uso está **restringido a pacientes con corazón sano**, ya que aumentan el riesgo de arritmias malignas (como **Taquicardia Ventricular**) en presencia de cardiopatía estructural o disfunción ventricular izquierda.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el contexto de la **Fibrilación Auricular (FA)**, es crucial distinguir entre el control de la frecuencia y el control del ritmo. La elección depende de las características del paciente y la presencia de comorbilidades.

Intervenciones No Farmacológicas para el Control del Ritmo

- Cardioversión eléctrica**: Método que utiliza una descarga eléctrica sincronizada para restaurar el ritmo sinusal. Es una opción fundamental en situaciones de urgencia o cuando los fármacos no son efectivos.
- Ablación con radiofrecuencia**: Procedimiento invasivo que busca eliminar o aislar eléctricamente las zonas del tejido cardíaco que

originan o perpetúan la FA, interrumpiendo los circuitos de reentrada auricular. Se reserva para casos seleccionados de FA.

Contraindicaciones de Antiarrítmicos

La elección del antiarrítmico adecuado requiere conocer sus contraindicaciones para evitar efectos adversos graves.

Beta-bloqueadores (Clase II)

- Asma bronquial y EPOC grave**: Pueden agravar la obstrucción bronquial.
- Diabetes Mellitus con riesgo de hipoglicemia**: Enmascaran los síntomas simpáticos de la hipoglicemia (taquicardia, temblor), dificultando su detección.
- Hipotensión arterial**
- Insuficiencia cardíaca aguda muy descompensada**: Debido a sus efectos inotrópicos negativos e hipotensores.

Bloqueadores de los Canales de Calcio no Dihidropiridínicos (Verapamilo, Diltiazem - Clase IV)

- Hipotensión arterial**
- Insuficiencia cardíaca**: Tienen efectos inotrópicos negativos, disminuyendo la fuerza de contracción cardíaca.

Digitales (Digoxina - Clase V)

- Insuficiencia renal crónica**: Son relativamente tóxicos y tienen un estrecho rango terapéutico. La acumulación en pacientes con insuficiencia renal puede llevar a intoxicación, manifestada por arritmias (ej., bradicardias, bloqueos AV) y síntomas gastrointestinales o neurológicos.
- Wolf-Parkinson-White (WPW) con FA**: La digoxina puede acortar el período refractario de la vía accesorio, aumentando la conducción por esta vía y el riesgo de **Fibrilación Ventricular (FV)**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca uses **digitales** en pacientes con **Síndrome de Wolf-Parkinson-White (WPW)** y **Fibrilación Auricular (FA)** debido al riesgo de precipitar **Fibrilación Ventricular (FV)**.

Amiodarona (Clase III)

- Síndrome de Wolf-Parkinson-White (WPW) con FA**: Riesgo de arritmias ventriculares graves.
- Fibrosis pulmonar**: Es una complicación clásica de la amiodarona, por lo que está absolutamente contraindicada si ya existe o si el paciente tiene alto riesgo.
- Disfunción tiroidea (hiper o hipotiroidismo)**: La amiodarona contiene yodo y puede inducir o agravar estas condiciones. Se debe monitorizar la función tiroidea.

Bloqueadores de los Canales de Sodio (Clase IC: Flecainida, Propafenona)

- Cardiopatía estructural o Insuficiencia cardíaca**: El riesgo de arritmias malignas (ej., **Taquicardia Ventricular**) es significativamente mayor en pacientes con enfermedad cardíaca subyacente. Su uso se limita a pacientes con **corazón sano**.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En la práctica clínica, la **amiodarona** es uno de los antiarrítmicos más utilizados para el control del ritmo en FA, a pesar de su perfil de efectos adversos que requiere monitorización. La **propafenona** se usa menos debido a la restricción a pacientes con corazón estructuralmente sano.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Hombre de 62 años con antecedente de infarto previo y FEVI 35% presenta FA paroxística recurrente pese a control de frecuencia con betabloqueadores. Se plantea estrategia de control del ritmo."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

En pacientes con cardiopatía estructural (FEVI reducida o infarto previo), el único antiarrítmico seguro para mantener ritmo sinusal es la Amiodarona. Flecaínida y Propafenona están CONTRAINDICADAS por riesgo proarrítmico. En corazón sano, Flecaínida es primera línea (pill-in-the-pocket).

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La FA es la arritmia sostenida más frecuente en la práctica clínica
- Los antiarrítmicos clase IC (flecaínida, propafenona) se usan solo en ausencia de cardiopatía estructural
- La amiodarona es el antiarrítmico más eficaz pero con mayor perfil de toxicidad
- En insuficiencia cardíaca con FEVI reducida, la amiodarona es el único antiarrítmico seguro para control de ritmo
- La estrategia pill in the pocket permite cardioversión ambulatoria con flecaínida o propafenona
- La amiodarona requiere monitorización de función tiroidea, hepática y pulmonar
- La dronedarona está contraindicada en insuficiencia cardíaca clase NYHA III-IV

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (FIBRILACIÓN AURICULAR: ANTIARRÍTMICOS)**PREGUNTA 1**

Paciente de 62 años con antecedente de infarto al miocardio hace 3 años, FEVI 35%, presenta fibrilación auricular paroxística recurrente. ¿Cuál es el antiarrítmico más apropiado para control de ritmo?

- A)** Flecaínida
- B)** Propafenona
- C)** Amiodarona
- D)** Dronedarona
- E)** Verapamilo

PREGUNTA 2

Mujer de 48 años, sin cardiopatía estructural, con episodios de FA paroxística cada 3-4 meses, bien tolerados. Se decide estrategia pill in the pocket. ¿Cuál fármaco es el más adecuado?

- A)** Amiodarona
- B)** Flecaínida
- C)** Digoxina
- D)** Sotalol
- E)** Lidocaína

PREGUNTA 3

Paciente en tratamiento con amiodarona crónica por FA permanente consulta por baja de peso, temblor fino y taquicardia sinusal. ¿Cuál es la complicación más probable?

- A)** Fibrosis pulmonar
- B)** Hepatotoxicidad
- C)** Hipertiroidismo inducido por amiodarona
- D)** Hipotiroidismo inducido por amiodarona
- E)** Neuropatía periférica

RESUMEN: FIBRILACIÓN AURICULAR: ANTIARRÍTMICOS

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia sostenida más frecuente en la práctica clínica. Se caracteriza por una activación auricular desorganizada que genera una respuesta ventricular irregularmente irregular. El manejo farmacológico con antiarrítmicos es fundamental tanto para el control del ritmo como para la prevención de recurrencias. Los antiarrítmicos se clasifican según Vaughan-Williams en cuatro clases. La clase IC (flecaínida, propafenona) se usa para cardioversión farmacológica y prevención de recurrencias en pacientes sin cardiopatía estructural. La clase III (amiodarona, dronedarona, sotalol) es útil en pacientes con cardiopatía estructural, siendo la amiodarona el antiarrítmico más eficaz pero con mayor toxicidad a largo plazo. La elección del antiarrítmico depende de la presencia o ausencia de cardiopatía estructural, la función ventricular y las comorbilidades del paciente. En pacientes sin cardiopatía estructural se prefieren fármacos clase IC, mientras que en presencia de disfunción ventricular o cardiopatía isquémica se prefiere amiodarona. Es esencial monitorizar los efectos adversos, especialmente la toxicidad tiroidea, pulmonar y hepática de la amiodarona.